

¿Qué es la autoestima?

Más allá de quererse a uno mismo

La autoestima no es sentirse bien con uno mismo todo el tiempo. Es la **valoración que hacemos de nosotros mismos**: cómo nos vemos, cuánto nos creemos merecedores de cosas buenas, y cómo nos tratamos cuando cometemos errores. Se construye a lo largo de la vida y puede cambiar.

— LOS TRES COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA

Autoeficacia

¿Confío en mi capacidad de actuar?

La creencia de que podemos enfrentar desafíos y lograr lo que nos proponemos. Influye enormemente en la motivación y la persistencia.

Autoconcepto

¿Cómo me veo a mí mismo/a?

Las creencias sobre quiénes somos: cualidades, limitaciones, roles. No siempre refleja la realidad: puede estar distorsionado por experiencias pasadas.

Autoevaluación

¿Cómo me valoro?

El juicio que hacemos sobre lo que vemos. Alguien puede verse como “perfeccionista” y evaluarlo como positivo o negativo según su historia.

— SEÑALES DE AUTOESTIMA BAJA A RECONOCER

- Autocrítica muy intensa y persistente ante errores.
- Sensación de no merecer cosas buenas.
- Necesitar aprobación externa para sentirse bien.
- Dificultad para recibir reconocimiento o halagos.
- Compararse constantemente con otros de forma negativa.
- Evitar desafíos por miedo al fracaso.

La autoestima no se construye solo pensando diferente. También cambia con las acciones: lo que hacemos nos dice quiénes somos.

Cómo se forma y cómo se cambia la autoestima

Entender la autoestima para poder trabajarla

La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos — cuánto nos creemos dignos de amor, respeto y bienestar. **No es algo fijo** que tenemos o no tenemos: se construye y se puede cambiar.

— CÓMO SE FORMA LA AUTOESTIMA

- 1 Se construye desde temprano en relación a cómo fuimos **tratados, mirados y valorados** por los adultos significativos.
- 2 Las experiencias de logro y fracaso, aceptación y rechazo, van formando **creencias sobre uno mismo**.
- 3 Los mensajes internalizados (“soy capaz”, “soy deficiente”, “soy querido”) funcionan como un **filtro** que colorea cómo interpretamos todo lo que nos pasa.

— AUTOESTIMA BAJA, INFLADA Y SANA

Baja autoestima

Crítica interna severa, sensación de no merecer, comparación permanente y desfavorable, dificultad para recibir afecto.

Autoestima inflada

Dificultad para tolerar el error o la crítica, necesidad de validación constante, evitar la vulnerabilidad.

Autoestima sana

Reconocer fortalezas y límites con ecuanimidad, poder equivocarse sin perder el valor propio, no depender del juicio externo.

La autoestima no se repara con logros o validación externa — se construye cambiando la relación con uno mismo desde adentro.

Lo que me hace especial

Descubrir mis cualidades

Todos tenemos cosas que se nos dan bien y cosas que nos hacen únicos. A veces nos olvidamos de verlas. ¡Este ejercicio es para recordarlas!

Si pudiera describirme en tres palabras, diría que soy...

1

2

3

— COMPLETÁ CADA PARTE CON UNA COSA TUYA

● Algo que se me da bien

● Algo que hice y me puso contento/a

● Una cosa que me gusta de cómo soy

● Algo lindo que me dijo alguien

● Algo en lo que soy bueno/a con mis amigos

● Una cosa que me gustaría aprender o mejorar

Autoestima: evaluación e intervención

Marco clínico para profesionales de salud mental

MARCO CONCEPTUAL · CREENCIAS NUCLEARES (BECK)

La autoestima baja suele organizarse en torno a **creencias nucleares negativas** sobre el self ("soy defectuoso/a", "no soy suficiente", "no soy querible"). Estas creencias activan sesgos atencionales y confirman la narrativa negativa. El trabajo clínico apunta a identificarlas, cuestionar su evidencia y construir narrativas alternativas.

— EVALUACIÓN CLÍNICA

Creencias nucleares

Explorar con flecha descendente. ¿Qué significa para vos ese error? ¿Y eso qué dice de vos?

Distorsiones cognitivas

Personalización, sobregeneralización, filtro mental, descalificación de lo positivo.

Origen del patrón

Experiencias tempranas, figuras de apego críticas, comparación crónica, bullying.

Impacto funcional

Evitación, dependencia de aprobación, dificultad para poner límites, perfeccionismo.

Recursos existentes

Áreas de autoeficacia, red de apoyo, logros pasados. Construir desde lo que hay.

— INTERVENCIONES CON EVIDENCIA

TCC — Reestructuración de creencias nucleares

Registro de creencias, experimentos conductuales, técnica de la flecha descendente. Fennell (1997).

ACT — Defusión y yo-contexto

Separar el self de la narrativa negativa. "Tengo el pensamiento de que soy un fracaso" vs. "soy un fracaso".

Terapia de autocompasión (MSC)

Programa estructurado basado en Neff & Germer. Alta evidencia en reducción de autocrítica y vergüenza.

Activación conductual

Acciones alineadas con valores generan evidencia de capacidad. Más efectivo que el trabajo cognitivo puro.

CLAVE CLÍNICA

La autoestima baja rara vez es el problema principal: suele ser el resultado de experiencias de invalidación, crítica crónica o falta de afecto. Trabajar solo el pensamiento sin atender el origen suele ser insuficiente.